



종합감사
(2019-011)

감사결과 통보서

- 양산부산대학교병원 감염관리팀 -



2019. 12.

부산대학교병원 감사실



목 차 (index)

I . 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상기간	3
3. 감사실시 과정	5
4. 감사결과 처리	5
II . 감사대상 현황	6
1. 부서운영 분야	6
2. 주요업무 분야	8
3. 업무개선 사례	11
III . 감사결과	12
1. 총평	12
2. 지적사항 총괄	14
IV . 처분요구와 통보사항	14
1. 처분요구사항 일람표	14
2. 처분요구상세	14
(1) 전 직원 대상 감염교육 실적관리 미흡	15
(2) 원내 공사 시 감염위험도 사전평가 미흡	17
(3) 감염관리위원회 회의결과 관련부서 미공유 및 규정정비 미흡 ..	19
(4) 감염관리 예산 편성 및 집행 미흡	21



I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 양산부산대학교병원 감염관리팀(이하 “양산 감염관리팀”이라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 방안, 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 감사실에서 수립한 2019년 자체 감사계획에 따라 양산 감염관리팀에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상기간

이번 감사는 양산 감염관리팀에서 제출한 감사자료¹⁾에 나와 있는 주요업무들이 병원의 각종 규정과 정책 등에 맞게 이루어지는지를 중점적으로 점검하는 한편, 양산 감염관리팀 소속 직원들에 대한 복무관리 실태, 업무추진비 사용내역 등과 같은 부서운영의 적정성을 점검하는 데 감사의 중점을 두었다. 그리고 이러한 점검은 양산 감염관리팀이 2016. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지 수행한 업무로 한정하여 검토하였다.

1) 감염관리팀-2742(2019.11.14.) 양산 감염관리팀 종합감사 감사자료 제출

양산 감염관리팀 종합감사 중점

■ 주요업무에 관한 사항

- 감염관리 교육에 관한 사항
- 감염관리위원회에서 의결된 실무에 관한 사항
- 감염에 대한 부서 간 업무조정에 관한 사항
- 법정감염병 관리 및 감염환자 처리에 관한 사항

■ 부서운영 등에 관한 사항

- 업무추진비 등 부서경비 정산의 적정성에 관한 사항
- 부서 자산관리의 적정성에 관한 사항
- 청탁금지법 및 임직원행동강령 준수 여부에 관한 사항
- 일상감사 대상사업 수감 여부에 관한 사항

■ 복무관리 등에 관한 사항

- 개인근태관리(휴가 등)의 적정성에 관한 사항
- 관외출장 신청의 적정성 및 출장복명서 제출 등에 관한 사항
- 외부강의 발생 시 사전신고 현황에 관한 사항



3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2019. 11. 7. ~ 11. 8., 2일간)를 거쳐 2019. 11. 11.부터 같은 해 11. 22.까지 10일간 감사인원 8명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

주요 업무분야의 쟁점을 확인하기 위해 최근 3년간 법정 감염병 신고 현황, 전직원 감염관리교육 실시 현황, 감염관리위원회 회의개최 현황, 감염위험도 평가 실시 현황, 감염관리팀 예산 편성 및 집행 현황, 주사침 자상사고 등 직원 감염사고 처리 현황 등과 관련된 서류를 제공받아 검토하였으며 부서 운영의 적정성을 확인하기 위하여 업무추진비 사용내역 및 자산관리 실태 현황을 점검하였고, 양산 감염관리팀 구성원들의 복무관리 실태를 확인하기 위하여 양산병원 정보시스템인 ‘YES’ 에서 출장·휴가내역·외부강의 신고 현황 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 개선사항 및 규정위반 사항 등과 관련하여 양산 감염관리팀으로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 감염관리팀장 외 담당자 1명이 참석한 가운데 2019. 11. 22. 감사마감회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2019. 12. 24. 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사대상 현황

1. 부서운영 분야

가. 조직 · 인원 현황

양산 감염관리팀은 감염의 발생 감시, 감염관리 실적의 분석 및 평가, 직원의 감염관리교육 및 감염과 관련된 직원의 건강관리 등의 업무를 수행하기 위하여 「직제규정」 제7조(진료지원부서)에 따라 진료처 밑에 편제되어 업무를 수행하고 있다.

양산 감염관리팀은 진료처 감염관리실장 아래 감염관리팀 분장 사무를 수행하기 위하여 부서관리자인 감염관리팀장 1명, 간호직 8명 등 총 9명으로 구성되어 있다. 양산 감염관리팀 구성도는 [그림 1]과 같으며 인력현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 양산 감염관리팀 구성도



[표 1] 최근 3년간 양산 감염관리팀 인력현황

(단위 : 명)

연도	구분	1급	2급	3급	4급	5급	소계	휴직	총계
2016 ¹⁾	간호직	-	-	1	6	1	8	-	8
2017 ¹⁾	간호직	-	-	1	6	1	8	-	8
2018 ¹⁾	간호직	-	-	1	7	1	9	1 (육아휴직)	10

주1) 작성기준일 : 각 연도별 12.31. 기준(육아휴직 포함)

나. 부서예산 현황

최근 3년간 양산 감염관리팀의 예산배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 최근 3년간 양산 감염관리팀 예산 집행현황

(단위 : 원)

구 분	2016년	2017년	2018년	비 고
배 정	31,640,000	30,793,200	207,660,000	
지 출	27,853,220	26,691,300	54,249,455	
집행률	88%	87%	26% ¹⁾	

주1) 예산 집행률이 2018년 26%로 저조한 원인 분석

: 잠복결핵 1차 검사 시 실제 금액 집행액은 53,351,910원이었으나, 양산 감염관리팀 담당자 오기로 예산합의서에 5,335,191원으로 금액 기입을 하여 예산집행률이 저조하게 되었으며, 정례행사비로 3,400,000원 예산액을 책정하였으나, 물품구입 비용을 감염관리실 예산에서 집행하지 않고 자산관리팀에서 구매 집행하여 3,150,000원의 차액 발생함.(2018년 예산편성 및 집행관리 부적정)

2. 주요업무 분야 및 현황

양산 감염관리팀 주요 업무 내용은 [표 3]과 같다.

[표 3] 양산 감염관리팀 주요 업무 요약표

주요업무	세부사항	추진시기
의료관련 감염 발생감시 확인	□ 요로감염, 혈류감염, 폐렴, 수술부위감염 □ 전 병동 (중환자실, 병동) □ 보고서 검토 (중환자실-월, 병동-분기)	연중
접촉격리균주 별 감염 발생감시 확인	□ VRE, C.difficile, rota virus □ 보고서 검토 (분기별) □ 격리 해제 문의 대응	연중
다제내성균주 별 감염 발생감시	□ MRSA, ESBL 생성 E.coli, K.pn, MRAB, MRPA □ 보고서 작성 (분기별) □ 격리 해제 문의 대응	연중
감염 유행 발생 시 대처	□ 역학조사 □ 중재활동 □ 보고서 검토	연중
위원회 운영	□ 감염관리위원회 활동 □ 간호감염관리위원회 활동	연중
모니터링 활동	□ 손 소독제 사용량 모니터링 □ 세탁업체 포함 중앙공급실 모니터링 □ 급식관리실 모니터링 □ 환경배양검사 결과 모니터링 □ 중환자실 MBP check list 모니터링	연중
교육 및 홍보에 관한 사항	□ 의사, 간호사 교육 □ 감염관리행사 참여 □ 감염관리소식지 발행 □ 감염관리 관련 포스터, 교육자료 제작	연중
외부평가 대비	□ 의료기관 인증 평가	연중
자문 및 조정	□ 원내·외 질문자에게 최신 정보 제공 □ 타부서 질 향상 활동 자료제공 및 협조 □ 국정감사 요청 자료 제공 □ 감염관련 물품 도입 시 검토	연중

가. 연도별 주요사업 추진실적

(1) 사업 추진비용 10,000,000원 이상인 사업

[표 4-1] 연도별 주요사업 추진실적 현황

(단위 : 천원)

연도	건명 및 사업내용	예산액	집행액	집행률(%)	사업성과
2016	o 2016년도 의료관련 감염병 표본감시사업 <국고보조금 사업>	19,500,000	19,500,000	100	본원의 다제내성균 6종 발생 추이 파악 : 본원 의 다제내성균 획득 정 도 파악
2017	o 2017년 의료관련 감염병 예방·관리 사업(중심병원) <국고보조금 사업>	23,000,000	23,000,000	100	참여병원 감염관리 전 문성향상을 위한 기술 적 지원 : 참여병원 대 상 교육 및 워크숍 시 행, 현장자문이행
2018	o 2018년 의료관련 감염병 예방·관리 사업(중심병원) <국고보조금 사업>	22,000,000	22,000,000	100	참여병원 감염관리 전 문성향상을 위한 기술 적 지원 : 참여병원 대 상 교육 및 워크숍 시 행, 현장자문이행

(2) 최근 3년간 업무추진비 사용 현황

[표 4-2] 업무추진비 사용 현황

(단위 : 원)

연도 업무추진비내역	2016			2017			2018		
	수입	비용	집행률(%)	수입	비용	집행률(%)	수입	비용	집행률(%)
진료지원과 운영비	354,000	383,860	108	218,000	228,050	104	1,246,000	1,426,000	114
중앙지원비	2,560,000	2,560,610	100	2,400,000	2,399,910	100	2,280,000	2,280,349	100

나. 의료기관 인증평가 결과보고서(감염관리팀 지적사항 및 조치이행 결과)

[표 4-2] 감염관리팀 지적사항 및 조치이행 결과

연번	의료기관 인증평가 지적사항	조치이행 결과
1	수치료실 수질관리, RO수 관리는 양호하나, 치과외래 수관관리는 사용하지 않는다는 사유로 관리 미흡. [수관 물빼기나 배양검사 시행하지 않음.] 향후 치과 유닛에 대한 관리를 지속적으로 시행하시기를 권고함.	매달 배양검사 시행중임. 치과수관에 균 검출되어 배관 교체공사 및 채취방법 검토 중임.
2	손위생 수행을 돕기 위한 자원 부분 정책에 추가	제공중인 손 위생 자원이 정책내에 구체적으로 반영되어 있지 않던 상태로 내부 논의 후 정책 반영 예정
3	법정감염병(VRE, CRE) 환자임을 알리기 위해 병실 문 앞에 부착하는 스티커 사이즈의 크기를 크게 변경할 것을 권고함.	기존에 VRE, CRE 격리 환자의 경우 10*10size 스티커 부착토록 하였고 준수 모니터링 시행 중임.
4	유행성 감염병 선별진료 절차 재검토(열이 없고, 본인이 메르스 환자임을 알리지 않고 응급실 오는 경우 선별에 대한 한계점 있음)	1. 인력충원 필요 상주 인력 추가 : 최소 5명 인력 충원은 최소 11명은 되어야 함(원무 : 5명, 간호사 : 소아 1명, 응급구조사: 5인 이상) -> 인력충원 요청하였으나 비용문제로 보류 2. 시설 개선 중증음압구역과 소아, 성인 응급실 진료구역 멀리 떨어져 있어 구조적 변경이 필요하여 검토해야 함. 트리아제 → 접수/수납 → 중증음압구역으로 바로 연결되게 시설이 변경되어야 함. -> 인력충원이 되어야만 진행 가능하므로 보류됨. 3. 교육 중증구역에서 근무하는 경력간호사가 교육(Level D, PAPR) 실시함.

3. 양산 감염관리팀 업무개선 사례(2016년 ~ 2018년)

□ 의료관련 감염예방을 위한 증진 활동

○ 필요성

- 2016년 6월 타병원에서 출생 후 양산부산대병원으로 전원 온 MDRAB²⁾ 환자(재원기간 20일, MDRAB 패혈증으로 사망) 치료 이후 간헐적으로 MDRAB 환자들이 집중치료실 내 발생하였고 2018년 1월 발생 건수가 가장 증가하여 감염병 확산을 조기에 차단하기 위해 유행 조사를 시행함.

○ 개선활동

- 감염예방 활동 강화하고 관계직원에 대한 감염관리교육 실시함.
- 적극적 추적관찰 실시 : 집중치료실 주 1회 주변 환경 배양검사 실시함.
- 관련 의료진 MDRAB 보균자 검사 실시함.
- 감염관리 및 손 위생 모니터링 강화함.
- 호흡기 관련 감염관리 활동 시행 : MDRAB 보균환자의 분비물 suction(흡인) 시 차단하여 suction 시행함.
- 집중치료실 감염예방을 위해 관련부서 출입관리 강화함.

○ 기대효과(활동결과)

- 집중치료실 내 MDRAB 발생 유행이 완전하게 종식됨.

2) MDRAB(Multi-Drug Resistant Acinetobacter Baumannii): 다제내성아시네토박터바우마니균

1. 정의 : 카바페넴계, 아미노글리코사이드계, 플로로퀴놀론계 항생제에 모두 내성을 나타내는 아시네토박터 바우마니균의 감염증.
2. 발생원인 : 아시네토박터는 토양이나 물속에 널리 존재하며 건강인은 감염위험이 매우 적으나 면역저하자, 만성폐질환자, 당뇨 환자는 감염에 취약함. 입원환자, 특히 인공호흡기 사용환자, 장기간 입원환자에 감염을 유발할 수 있음.
3. 증상 : 폐렴, 혈류감염, 창상감염을 유발할 수 있으며, 감염부위에 따라 다양한 증상을 나타냄.
4. 치료 : 감염증 치료시 항생제 감수성 시험에 근거하여 감수성 있는 항생제로 치료함.
5. 예방 : 전파경로 : 직, 간접 접촉 및 오염된 의료기구, 환경 등을 통해 전파됨.
6. 감염된 환자, 감염원과 접촉한 사람의 손 또는 오염된 의료기구 등을 통해서 전파 가능하므로 철저한 손위생과 의료기구의 소독/멸균을 철저히 시행하고 침습적인 시술시 무균술을 지키며 환경표면의 청소와 소독이 필요함.



III 감사결과

1. 총 평

양질의 의료 시스템에 대한 사회적 관심이 증가하면서 병원의 감염관리가 주목을 받고 있다.

감염관리 간호사는 표준화된 감염관리 지침을 만들어 감염이 발생하지 않도록 사전 예방 작업을 하며 감염이 발생했을 때 보고, 조사 등을 실시하고, 또 감염지침을 놓고 직원들을 대상으로 감염관리 교육을 하거나 자문에 응하기도 하는 의료관련 감염전문가다.

이들의 역할은 이렇게 감염에 대한 감시와 보고, 감염관리 정책과 규정작성, 직원들의 감염관리 교육과 자문, 감염 발생 조사 등으로 나뉜다.

2018년 집중치료실 내에서 MDRAB 환자가 발생했을 때 주관부서인 양산 감염관리팀에서는 관련부서인 진단검사의학과, 흉부외과, 소아청소년과, 소아간호팀, 특수간호2팀과 협의를 거쳐 2018년 2월부터 2018년 8월까지 약 6개월 간 관련 의료진들에게 MDRAB 보균자 검사를 시행하고, 주 1회 집중치료실 주변 환경에 대해 배양검사를 시행하는 등 적극적인 감염예방 활동을 펼친 끝에 MDRAB 발생을 완전히 종식시키는 성과를 올린 사실은 감염관리팀의 기능과 역할이 어떠한 것인지를 잘 보여주는 모범적 사례라 할 것이다.

그러나 이번 감사를 통해 확인한 결과 전 직원 감염관리교육의 대부분이 사이버교육 위주로 이루어지고 있었으며, 감염관리실 주관의 집체(현장)교육은 미흡한 수준이었다.

그리고 집체(현장)교육 증빙자료를 확인해 본 결과, 2016년 4건, 2017년 1건, 2018년 2건은 참석자 명단 없이 참석 인원만 숫자로 표시되어 있었고 자필 서명과 교육 장면 사진도 누락된 사실이 확인되어 직원들이 병원 내 감염 발생을 예방할 수 있는 능력을 키울 수 있도록 실제적인 감염관리교육이 이루어지도록 할 것과 교육 이수 실적 관리도 철저히 할 것을 요구하였다.

감염위험도 평가 부문에서는 병원 내 공사 시 미생물과 분진의 확산을 막고 환자 뿐 아니라 직원과 방문객, 장비와 기구 등을 오염물로부터 보호하여 병원 감염이 발생하는 것을 최소화하기 위해 사전에 감염위험도 평가를 실시하여야 하나 이런 절차를 지키지 않고 공사를 시행한 사실이 발견되었다. 이에 감염관리팀에서는 공사 전에 감염위험도 평가를 실시할 수 있도록 공사 주관부서와 협의하는 등 업무 체계를 정비하고 수시로 공지, 점검하여 감염위험도 평가가 누락되지 않도록 철저히 관리해줄 것을 요구하였다.

한편, 양산부산대학교병원 감염예방 및 관리정책(IC-13/5.2)에 따르면, 감염관리 위원회 회의결과는 반드시 병원장 결재를 받고 관련부서와 내용을 공유하여 문제점을 분석하고 해결방안을 모색하여야 함에도 양산 감염관리팀에서는 위원회 회의결과를 관련부서와 미공유한 사실이 확인되었으며, 감염관리위원회 운영에 있어서도 규정상 위원을 7~15인 이내로 하여야 함에도 실제로는 21~24인으로 위원 수를 초과하여 운영하고 있어 규정을 정비토록 요구하였다.

예산 편성 및 집행과 관련, 감염관리팀의 잠복결핵 검진예산의 책정 및 집행내역을 확인한 결과 잠복결핵 검사 시 53,351,910원이 집행되었으나, 예산합의승인서에는 5,335,191원으로 단위를 잘못 입력하여, 예산집행률이 현저히 낮아지는 결과를 초래하였다. 또 정례행사비의 경우 당초 3,400,000원을 예산액으로 책정하였으나, 감염관리주간행사관련 물품을 구매할 때 자산관리팀을 통해 구매함으로써 감염관리실 예산이 집행되지 않아 3,150,000원의 차액이 발생하여 2018년도 예산집행률이 26%로 낮아졌음을 확인하고 예산 편성 및 집행에 철저를 기할 것을 요구하였다.



2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (기타)	주의 (인원)	경고 (인원)	개 선	권 고	통보					고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례 (인원)		
4								2	2							

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부 서	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	양산부산대학교병원 감염관리팀	전 직원 대상 감염 교육 실적관리 미흡	권고	—	—	처분 후 2개월내	—
2	"	원내공사 시 감염위 험도 사전평가 미흡	권고	—	—	"	—
3	"	감염관리위원회 회의 결과 관련부서 미공 유 및 규정정비 미흡	개선	—	—	"	—
4	"	감염관리 예산편성 및 집행 미흡	개선	—	—	"	—

2. 처분요구상세



양산부산대학교병원

권 고

제 목 전 직원 대상 감염교육 실적관리 미흡
소관부서 양산부산대학교병원 감염관리팀
조치부서 양산부산대학교병원 감염관리팀
내 용

의료기관 인증평가 관련지침 중 감염관리 부문(감염관리 교육) 기준에 따르면 양산부산대학교병원 감염관리팀에서는 전 직원 대상으로 필수적으로 감염관리 교육을 실시하고 교육이수 실적을 철저히 기록·보관하여야 한다.

이는 병원 내 발생하는 감염을 사전에 예방하여 환자 및 보호자, 내원객 및 모든 직원을 의료감염으로부터 보호하기 위함이다.

그런데, 양산부산대학교병원 감염관리팀에서는 전 직원 감염관리교육의 대부분이 사이버교육 위주로 이루어지고 있었으며, 아래 【표】와 같이 감염관리팀 주관의 집체(현장)교육은 미흡한 수준이었다.

【표】 감염관리교육 이수 현황

(단위 : %)

연도	2016	2017	2018
집체(현장)교육	27	90 3)	57
사이버교육	67	71	79

주3) 2017년도 집체(현장)교육 이수율 90% 사유

: 2017년도의 경우 현장(부서별 심화교육 후 전달)교육이 활발하였으나, 2018년도의 경우 근무시간 이후 교육 시 초과수당 지급요구로 부서별 심화 현장교육이 축소되고 사이버위주로 진행되어 실제적인 현장교육 비율이 57%로 낮아짐.

또한, 집체(현장)교육 증빙자료를 확인해 본 결과, 2016년 4건, 2017년 1건, 2018년 2건은 참석자 명단 없이 참석 인원만 숫자로 표시되어 있었고 자필서명과 교육장면 사진도 누락되어 있었다.

비록 의사직, 보건직, 행정직, 원무직 등 여러 인력이 공존하고 있는 병원 특성상 모든 직원들에게 집체교육을 시키는 것은 현실적으로 힘든 점을 감안하더라도 감염은 환자안전과 직결되어 있는 만큼 감염관리 교육의 중요성을 인식하여야 한다.

따라서, 양산부산대학교병원 감염관리팀은 직원들이 보다 정확하고 상세한 교육을 받아 병원 내 감염 발생을 예방할 수 있도록 보다 적극적이고 실제적인 감염관리 집체교육을 실시할 필요가 있다. 또한 그런 교육의 이수 실적도 철저히 관리해야 할 필요가 있다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

전 직원 감염관리교육이 현장중심의 실제적인 교육이 될 수 있도록 현재 사이버 위주의 교육에서 향후에는 ①집체(현장)교육의 비율을 확대하도록 하고, 교육 실시 후 ②이수확인을 위해 교육 참석자 자필서명, 교육장면 사진을 남겨서 교육실적 관리를 철저히 하도록 조치하시기 바랍니다.(권고)



양산부산대학교병원

권 고

제 목 원내 공사 시 감염위험도 사전평가 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 감염관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 감염관리팀, 시설관리팀

내 용

양산부산대학교병원 감염관리팀은 병원정책(정책번호 IC-24) 『건축과 개보수 관련 감염관리 정책』에 따라 병원 건물의 건축, 개보수 및 철거 시 공사유형과 구역별 위험 환자군을 분류하여 등급을 정하고, 그 등급에 따라 감염 위험도를 평가하고 예방관리 및 대책 활동을 수행하고 있다.

이는 병원 내 공사 시 미생물과 분진의 확산을 막고 환자 뿐 아니라 직원과 방문객, 장비와 기구 등을 오염물로부터 보호하여 병원감염이 발생하는 것을 최소화하기 위함이다.

그러나 최근 3년간(2016~2018) 감염관리팀 감염위험도 평가 실시 현황을 보면 아래 【표】와 같이 병원 내 감염원 노출 우려가 있는 공사 건수에 비해 위험도 평가 건수가 낮다는 것을 알 수 있다.

【표】 감염위험도 평가 실시 현황

(단위 : 건)

연도	원내 공사 (시설관리팀)	위험도평가 실시 (감염관리팀)	위험도평가 (미실시)	비고
2016	15	10	5	통합 평가 2건 포함
2017	10	4	6	
2018	13	2	11	

* 자료출처 : 원내공사(시설관리팀), 위험도평가(감염관리팀)

또한, 감염관리팀은 공사의 주관부서로부터 감염관리 위험사정을 의뢰 받아 위험도 평가를 시행해야 하며, 이 사전 작업이 완료된 연후에 주관부서는 공사에 착수해야 한다. 하지만 복합적인 요인들로 인해 선 공사, 후 평가로 진행되거나, 위험도 평가를 생략한 채 공사를 시행한 사실도 발견되었다.

따라서, 감염관리팀에서는 공사 전에 감염위험도 평가를 실시할 수 있도록 공사 주관부서와 협의하여 업무 체계를 정비, 확립하고 수시로 공지하고 점검하여 평가가 누락되지 않도록 철저한 관리를 해야 할 필요가 있다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

병원 건물의 건축, 개보수 및 철거 시 감염위험도 평가를 사전에 실시할 수 있도록 관련부서와의 업무 체계를 확립하고, 의료관련 감염발생이 생기지 않도록 조치하시기 바랍니다.(권고)

양산부산대학교병원

개 선

제 목 감염관리위원회 회의결과 관련부서 미공유 및 규정 정비 미흡
소관부서 양산부산대학교병원 감염관리팀
조치부서 양산부산대학교병원 감염관리팀
내 용

양산부산대학교병원 감염예방 및 관리정책(IC-13/5.2)에 따르면, 감염관리위원회 회의결과는 병원장 결재를 받고 관련부서에도 내용을 공유하여 문제점을 분석하고 해결방안을 모색하여야 한다.

또한, 양산부산대학교병원 위원회 운영규정 제 9조②항에 따라 감염관리위원회 위원 수는 위원장을 포함하여 7인 이상 15인 이내로 구성하여야 한다.

그런데 양산부산대학교병원 감염관리팀에서는 위원회 회의결과를 관련부서에 미전파한 사실이 확인되었으며, 또 감염관리위원회의 실제 위원수를 21~24인으로 운영하여 규정(7~15인 이내)보다 초과 한 사실이 있다.

【표】 감염관리위원회 운영 현황

(단위 : 건, 명)

연도	감염관리위원회			
	회의실시	회의결과 관련부서 미공유	규정상 위원회 위원 수	실제 참석 위원 수
2016	4	3	7 ~ 15	18 ~ 20
2017	4	0	7 ~ 15	16 ~ 22
2018	4	0	7 ~ 15	16 ~ 23

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

감염관리 개선활동에 반영될 수 있도록 ①감염관리 위원회 회의결과는 관련부서에 공유하도록 조치하시기 바라며, 위원회 위원 또한 실제 운영하고 있는 위원수에 맞도록 ②양산부산대학교병원 위원회 운영 규정을 정비될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)



양산부산대학교병원

개 선

제 목 감염관리 예산 편성 및 집행 미흡

소관부서 양산부산대학교병원 감염관리팀

조치부서 양산부산대학교병원 감염관리팀

내 용

양산부산대학교병원 감염관리팀은 「양산부산대학교병원업무분장시행세칙」에 의거하여 병원감염 감시, 감염에 대한 정보 및 자료수집, 감염관리교육, 감염에 대한 부서간 업무조정, 법정감염병 관리 및 감염환자 처리, 감염관리위원회 의결된 실무, 기타 감염관리에 필요한 업무 등을 수행하고 있다.

이에 따라 감염관리팀은 체계적인 감염관리업무 수행을 위해 연간 사업계획을 수립하고 있으며, 효율적인 예산 집행을 위하여 각 사업단위별 계획에 의한 예산을 책정하여 집행하고 있다.

그 중 잠복결핵 검진예산은 의료기관 종사자 보호 및 의료기관 이용자 보호 목적으로 지출하는 비용으로 2016년 8월 결핵예방법(결핵예방법 제11조, 제11조의2, 제34조, 시행규칙 제4조, 제4조의2)에 의거하여 집행하고 있다.

그러나 2016년부터 2018년까지 감염관리팀의 잠복결핵 검진예산의 책정 및 집행내역을 확인한 결과 1차 검사 시 53,351,910원이 집행되었으나, 예산합의 승인서에 5,335,191원으로 단위를 잘못 입력하여, 예산집행률이 현저히 낮아지는 결과를 초래하였다.

또한 정례행사비는 당초 3,400,000원을 예산액으로 책정하였으나, 감염관리 주간행사관련 물품을 자산관리팀을 통해 구매하여 감염관리팀 예산으로 집행되지 않아 3,150,000원의 차액이 발생하여 아래 【표】와 같이 2018년도 예산 집행률이 26%로 낮아졌음을 확인하였다.

【표】 연도별 예산 집행 현황

(단위 : 천 원, %)

연도	예산액	집행액	잔액	집행률
2016	31,640,000	27,853,220	3,786,780	88
2017	30,793,200	26,691,300	4,101,900	87
2018	207,660,000	54,249,455	153,210,545	26

「양산부산대학교병원 예산편성지침」에 따르면 모든 사업은 집행가능성 등을 고려하여 사업목적 달성에 필요한 최소 소요를 요구하여야 하며 예산 집행 부진사업은 분석과 면밀한 검토를 통해 사업 활성화 방안을 모색하고, 사업별로 적정예산을 편성하여 예비비 사용 및 이·전용을 최소화하여야 한다.

따라서 양산부산대학교병원 감염관리팀에서는 예산 수립 시 사업규모 및 병원 내 주요 정책을 사전에 고려하여 적정 예산을 편성하여야 한다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

예산 집행률이 낮은 부진사업을 분석하여 사업활성화를 도모하시기 바라며, 향후 예산 편성 시에는 사업규모, 전년도 집행률 등을 고려하여 적정예산을 편성하고 집행할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)